PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

# Rastreio e instrumentos validados

*Quatro decisões antes do número*

Psicologia do Esporte e Saúde Mental

RASTREIO NÃO É DIAGNÓSTICO

# O questionário abre a conversa, não fecha o diagnóstico



**pessoa sem queixa**

**13 pontos**

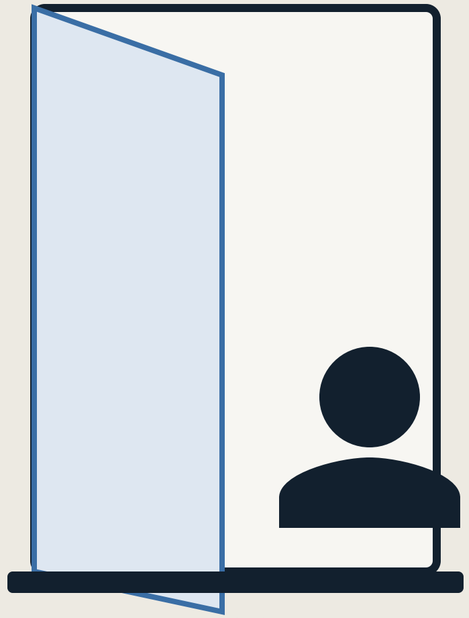
sinaliza probabilidade e abre uma conversa

**avaliação clínica**

**aqui está o diagnóstico**

> O que um positivo autoriza: “vale conversar com alguém especializado, e eu posso te ajudar a encontrar”.

# Antes do questionário vem o caminho



a soleira

**profissional de referência**
com quem você já conversou

**rede pública**
unidade básica → centro de atenção psicossocial

**emergência**
o número à mão, para o caso de risco

**E o resultado muda o que eu vou fazer? Se não muda, não aplique.**

O fluxo de encaminhamento completo é a próxima aula

SEGUNDA DECISÃO: QUAL INSTRUMENTO

# Cada instrumento responde a uma pergunta só

1. validado no Brasil?
2. que pergunta responde?
3. quanto tempo custa?
4. corte feito em quem?
5. o que muda se der positivo?

## Rastreio

**“vale olhar melhor?”**

fotografia

## Gravidade

**“quanto?”**

fotografia

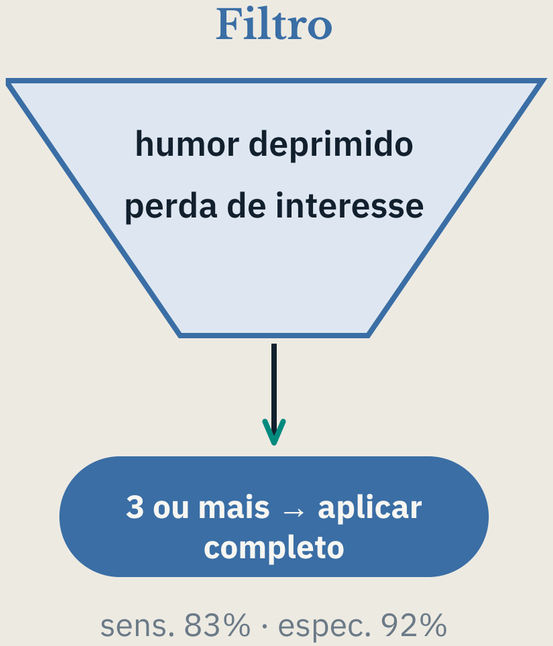
## Monitoramento

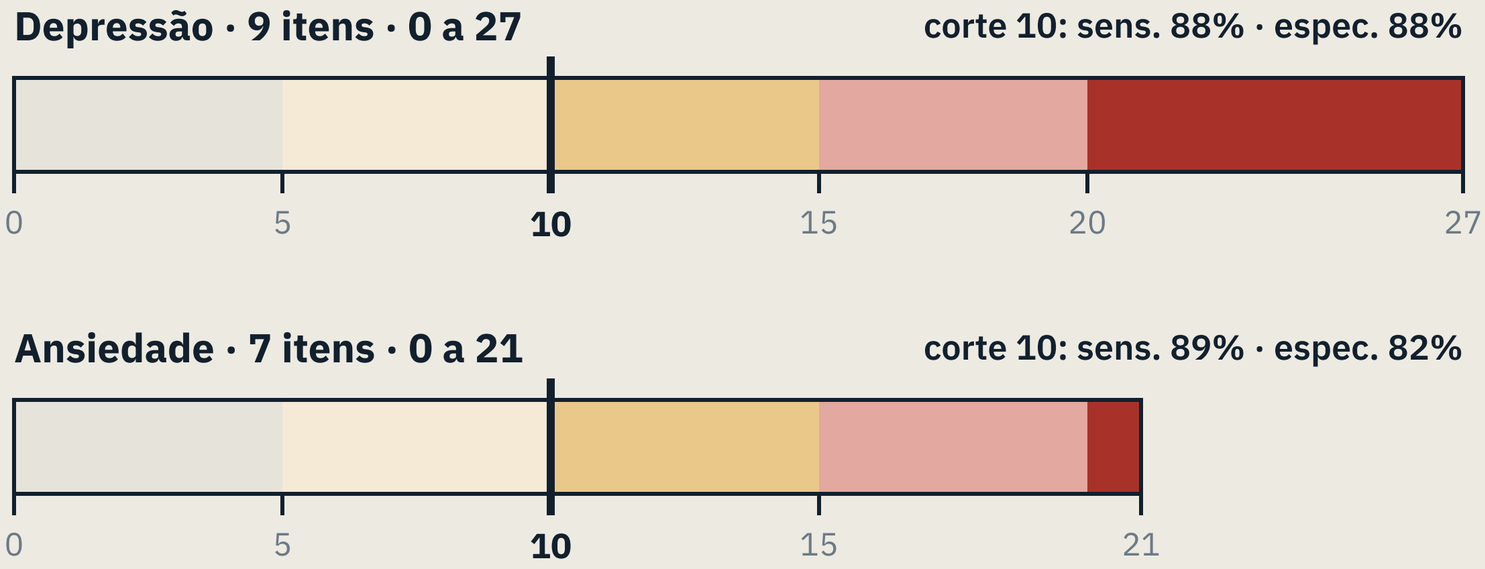
**“está mudando?”**

filme: só vale repetido

Entre dois que respondem a mesma pergunta, o mais curto: é o que chega respondido até o fim

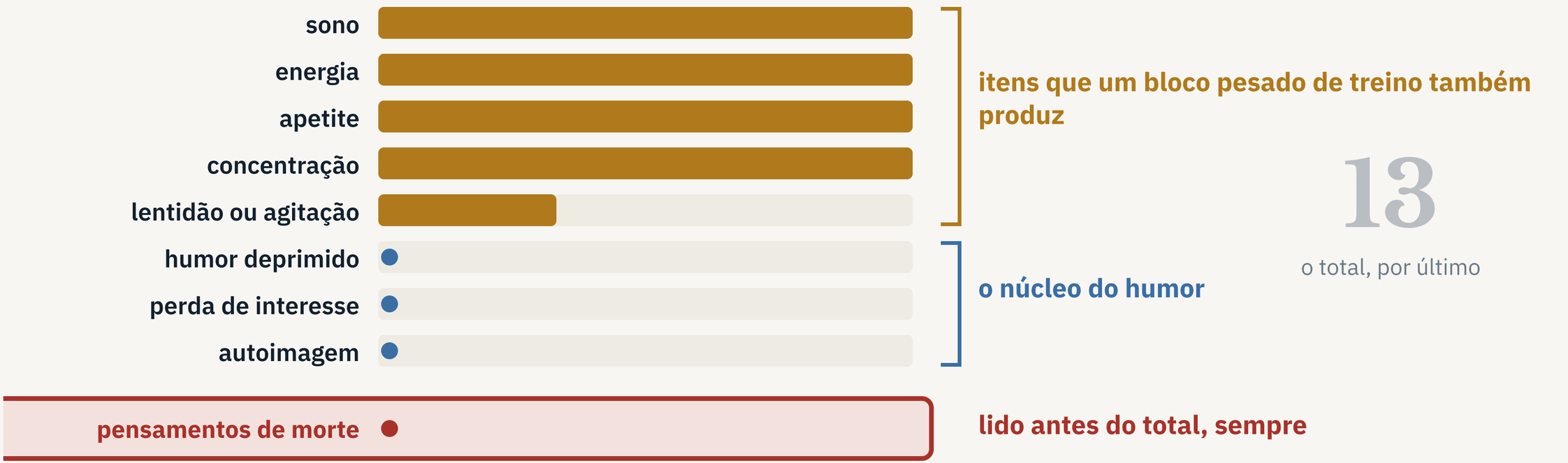
# Duas perguntas filtram, nove medem




Estudos originais em atenção primária, 2001, 2003 e 2006 · Pelotas, 447 adultos: corte acima de 9, sens. 77,5% · espec. 86,7%

# Leia os itens antes do total




13

o total, por último

Perfil ilustrativo, sem valores medidos · o inverso também acontece: quem aprendeu a suportar pontua baixo estando mal

# A ferramenta olímpica sobe em degraus e termina num clínico

**Reconhecimento**

para o atleta e o entorno: colegas, família, treinador

## 1 · Triagem

10 perguntas, de 10 a 50 pontos · 17 ou mais: risco aumentado

## 2 · Seis instrumentos específicos

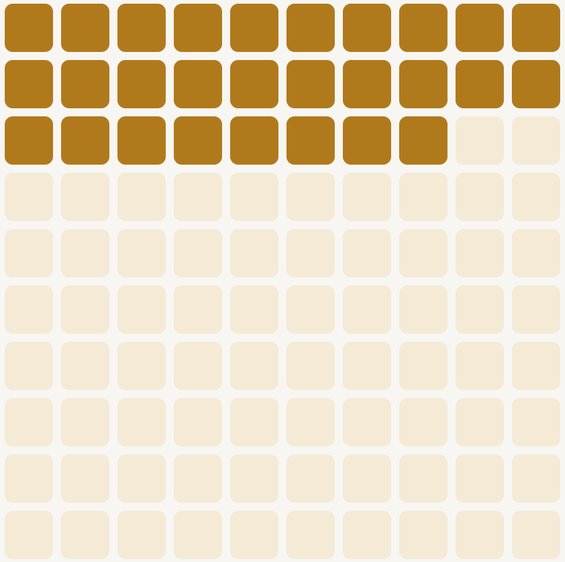
- ansiedade
- depressão
- sono
- álcool
- substâncias
- alimentação

## 3 · Avaliação clínica

médico do esporte ou profissional de saúde mental; aqui, e só aqui, o diagnóstico

# O mesmo escore vale mais onde o risco é maior

**prevalência 5%**

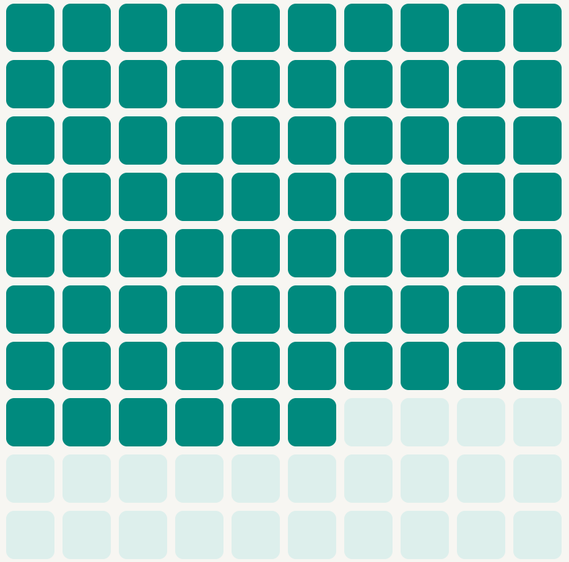


28

**de cada 100 positivos são reais**

44 reais em 158 positivos

**prevalência 30%**



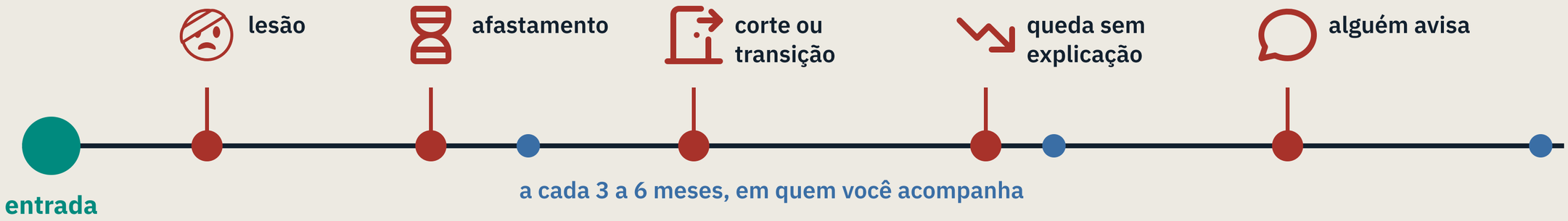
76

**de cada 100 positivos são reais**

264 reais em 348 positivos

Esquema, sem valores medidos · conta ilustrativa com sensibilidade e especificidade de 88% do estudo original e prevalências hipotéticas

# O momento e a frase decidem a resposta




**“faço com todo mundo”**
tira a sensação de ter sido escolhido

**“afeta o treino”**
entra pela porta que interessa

**“não é para te tirar de nada”**
desarma o medo de perder a vaga

Regra de equipe: o resultado individual não vai para o técnico. Combine antes, e cumpra.

RASTREIO E INSTRUMENTOS VALIDADOS

# “Ele está deprimido?” ainda não tem resposta

- Antes do questionário, o caminho
- Os itens antes do total, e o último item antes de todos
- O positivo vale o risco de quem você rastreia

### Quem treina e reabilita

Reconhece, apresenta o instrumento do jeito certo, encaminha.

### Médico

Aplica, lê item a item, conduz o que é clínico.

### Psicologia e psiquiatria

Fazem a avaliação que fecha o diagnóstico.